

경 고 사 항

1. 제 목 : 완화의료전문기관 지정요건 구비 지연 및 운영 불합리
2. 관계기관 : ○○병원
3. 내 용 : ○○병원에서는 완치가 불가능한 말기 환자와 그 가족들의 육체적·정신적 고통을 완화하고 인간다운 품위와 삶의 질을 유지하면서 생을 마무리할 수 있도록 지원하기 위하여 완화의료병동을 개설·운영하고 있습니다.

가. 지정요건 구비 지연

○○병원에서는 ‘15. 7. 1.호스피스 수가 건강보험 급여화에 따라 완화의료병동 운영을 계획하면서 당초에는 @@병동에 일반병상(21병상)과 완화의료병상(12병상) 등을 함께 운영하는 것을 추진하였으나, 완화의료병동 간병사업 운영 시 환자수요 및 공사비 등을 고려하여 @@병동 전체를 완화의료 병동으로 운영키로 계획을 변경하였습니다.

또한, 완화의료병동 공사는 @@병동 미운영에 따른 손실을 최소화하기 위하여 추석연휴 이후 추진하는 것으로 계획하여 ‘15.10. 1.부터 같은 달 15일까지 시행하였습니다.

위 공사의 주요 내용은 완화의료 병동 운영을 위한 전제 조건인 완화의료전문기관 지정을 위한 법적 시설 및 구비요건 충족 등을 위하여 기존 50병상 규모의 @@병동을 변경하여 30병상(최종 허가병상은 29병상) 규모로 조정하는 것입니다.

위와 같이 기존 병상을 축소 조정하여 새로운 병상을 운영코자 할 때에는, 새로운 병상 운영을 위한 지정기준 변경여부 등을 주기적으로 점검·대비하여 지정 절차 소요 행정일 등을 최소화함으로써 병상 축소운영에 따르는 손실을 예방할 수 있도록 하여야 합니다.

그런데 '15.10.23. 완화의료전문기관 지정 신청서류를 제출하면서 ㉹㉹㉹㉹팀 표준교육 미이수자는 온라인 교육으로 이수하겠다는 계획서를 첨부하였는데, 보건복지부에서 '15.10.16. 완화의료전문기관 질 관리를 위해 자격확보 교육과정은 오프라인 교육만 인정하는 것으로 지정기준을 강화함에 따라 지정신청이 반송되었고, ※※※센터 ♡♡♡♡♡사업단의 교육은 '15.10.28.로 오프라인 교육이 전국적으로 종료되어 연내 교육 이수가 불투명해지자, 권역 암센터로 지정되어 있는 □□□□병원과 협의하여 '15.11.29. ~ '15.12. 8.(총 60시간) 호스피스·완화의료 표준교육 전과정 특별반을 운영하여 교육 요건을 구비함으로써 '15.12.30.에야 완화의료전문기관으로 지정 받았습니다.

이에 따라 '15.10.21.부터 실질적으로 완화의료병동을 운영하였음에도 전문기관으로 지정일 이후부터 수가 적용이 가능하여 '15.12.31.에야 완화의료 수가를 적용함으로써 '15.10.21.~'15.12.30.까지는 병상을 축소(50→30병상) 운영하고도 완화의료 수가에 비하여 상대적으로 낮은 일반병동 수가를 적용받은 사실이 있습니다.

나. 완화의료 건강보험수가 적용

완화의료 건강보험수가는 입원료+행위료+약·치료재료 비용 등이 포함된 입원일당 정액수가를 기본으로 하되, 간호사 등의 인력확보 수준에 따른 가산수와 혈액암 환자에게 투여하는 수혈·투석치료, 완화의료 특성을 반영한 전인적 돌봄 상담료·임종관리료 등을 급여 별도산정 목록으로 구성되어 있습니다.

이와 같이 급여 별도산정 목록을 운영하는 사유는 해당 목록이 질 높은 완화의료 서비스 제공을 위하여 필요한 항목들이기 때문이므로 이들이 제외되지 않도록 관리하여 환자에게는 더 나은 서비스를 제공하면서 병원 경영에도 도움이 될 수 있도록 하여야 합니다.

[표 1] 완화의료병동 급여 별도산정 목록 미적용 내역('16.3.23현재)

등록번호	환자명	별도산정 불가내역
21----82	***	의사 상담 누락되어 전인적 돌봄 상담료 미적용
21----33	***	의사 상담 누락되어 전인적 돌봄 상담료 미적용
21----19	***	연휴로 돌봄 첫회 3일 이내 상담 누락으로 상담료 미적용
00----98	***	연휴로 돌봄 첫회 3일 이내 상담 누락으로 상담료 미적용
91----30	***	의사 임종상담 누락되어 임종관리료 미적용
00----27	***	입원 3일 이내 상담 시 초회돌봄 적용되나 의사 상담 지연
21----54	***	의사, 사회복지사 상담 누락으로 임종관리료 미적용
00----04	***	의사 상담 누락되어 전인적 돌봄 상담료 미적용
00----61	***	임종관리료 처방누락
00----23	***	의사, 사회복지사 상담 누락으로 임종관리료 미적용
00----52	***	연휴로 돌봄 첫회 3일 이내 상담 누락으로 상담료 미적용
91----78	***	의사 임종상담 누락되어 임종관리료 미적용
00----43	***	의사 상담 누락되어 전인적 돌봄 상담료 미적용
00----68	***	의사 임종상담 누락되어 임종관리료 미적용
00----46	***	의사상담 누락되어 돌봄 첫회 상담료 미적용
00----09	***	의사 , 간호사, 사회복지사 상담 누락되어 임종관리료 미적용
00----28	***	의사상담 시간부족(30분이상이나 15분 상담)으로 임종관리료 미적용
00----26	***	의사, 간호사, 사회복지사 상담 누락되어 임종관리료 미적용

그런데도 [표 1] 완화의료병동 급여 별도산정 목록 미적용 내역과 같이 상담 누락, 상담시간 부족 등으로 전인적 돌봄 서비스와 임종관리료 등을 적용받지 못한 경우가 '16. 3.23. 감사일 현재 18건에 달하는 것으로 확인되었습니다.

다. 완화의료병동 병상 가동률

병상 가동률은 투입된 자원의 활용도를 보여주는 지표로서 병원 경영을 반영하는 유효한 지표중 하나이므로 가동률 제고를 위하여 노력하여야 합니다. 한편 ○○병원을 포함한 병원 전체 병상 가동률은 평균 90%상당을 보이고 있습니다.

그런데 완화의료병동 29병상을 운영하고 있는 ○○병원의 완화병상 평균 가동률은 [표 2] 완화의료병동 병상 가동률과 같이 60%에 달하고 있습니다.

[표 2] 완화의료병동 병상 가동률('16. 3.23. 현재)

구분	16.1월	'16.2월	'16. 3.23	계
운영병상	899	841	667	2,407
가동병상	510	457	471	1,438
병상 가동률(%)	57%	54%	71%	60%

완화의료병동 가동률 제고를 위해서는 지역주민에 대한 홍보는 물론, 건강보험 요양급여 적용을 받아 환자들의 경제적 부담이 완화시킬 수 있는 측면이 있는 간병인 제도 조기 도입 등의 제도적 검토가 필요한 것으로 확인되었습니다.

라. 임종실 운영

완화의료병동은 시설 및 장비의 세부기준에 따라 입원실과 임종실, 목욕실, 가족실, 상담실, 처치실, 간호사실, 화장실 등을 구분된 별도의 공간으로 갖추도록 되어 있으며, 임종실을 이용할 경우 입원실(2~4인 기준 1일 290,060원)보다 높은 일당 정액수가(1일 355,040원)를 적용하도록 되어 있습니다.

이와 같이 임종실 이용 시 가산수를 인정하는 것은 마지막 가는 환자와 가족의 존엄성 유지와 함께 입원해 있는 다른 환자들의 심리적 안정 등을 고려하였기 때문입니다.

그런데 ○○병원에서는 현재 완화의료병동에 임종실 1실을 운영하고 있으나 완화의료 병상이 29병상으로 병상수가 많으며, 향후 병상 가동률 증가 등을 고려하여 임종실 추가 운영 방안도 검토하는 것이 필요한 것으로 확인되었습니다.

4. 조치할 사항

○ ○○병원장은

- 상담누락, 상담시간 부족 등으로 별도 산정이 가능한 급여(돌봄 등)를 적용받지 못하는 경우가 발생하지 않도록 관리하여 주시고(권고)
- 간병인 제도 조기 도입 등 완화병동 병상 가동률을 제고할 수 있는 방안을 검토하여 주시기 바라며(통보)
- 완화병동 병상수 등을 고려하여 임종실 추가 확보 방안을 검토하여 주시기 바랍니다.(통보)

○ ▼▼이사(○○병원장)는

- 완화의료전문기관 지정 요건을 지연 구비하여 완화병동 운영에 차질을 발생시킨 관련자에게 앞으로 동일사례 재발방지를 위하여 엄중 「경고」 조치하시기 바랍니다.